

REPETITOIRES

OPHTHALMOLOGIE
HOPITAL OPHTALMIQUE JULES GONIN

Alexandre Moulin, MER

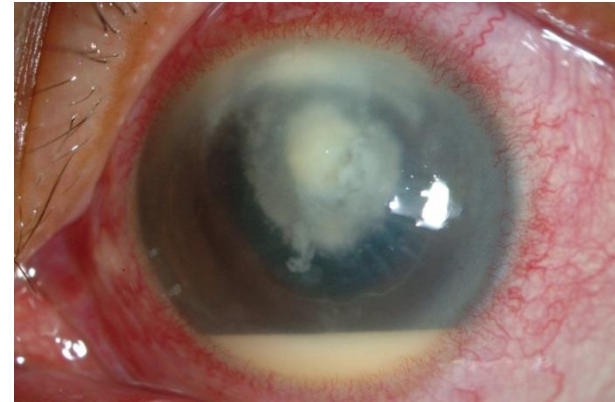
Question 1

Une femme de 44 ans porteuse de verres de contact, de retour d'un voyage en Indonésie, se plaint d'une diminution de la vision de son œil droit, d'une douleur oculaire ainsi que des difficultés à supporter la lumière.

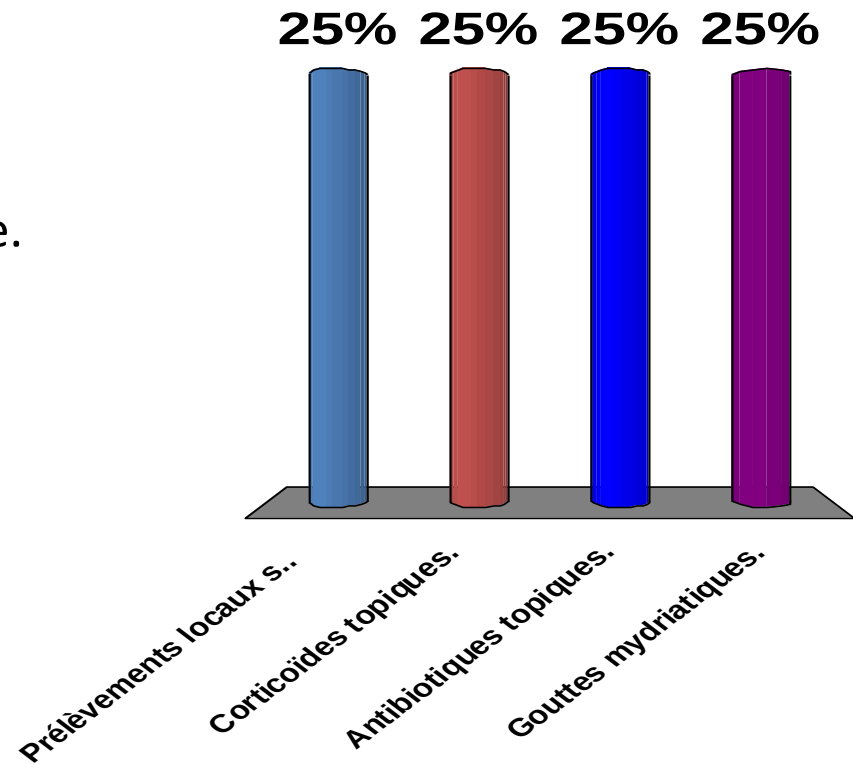


Quelle attitude n'est pas correcte?

Une femme de 44 ans porteuse de verres de contact, de retour d'un voyage en Indonésie, se plaint d'une diminution de la vision de son œil droit, d'une douleur oculaire ainsi que des difficultés à supporter la lumière.

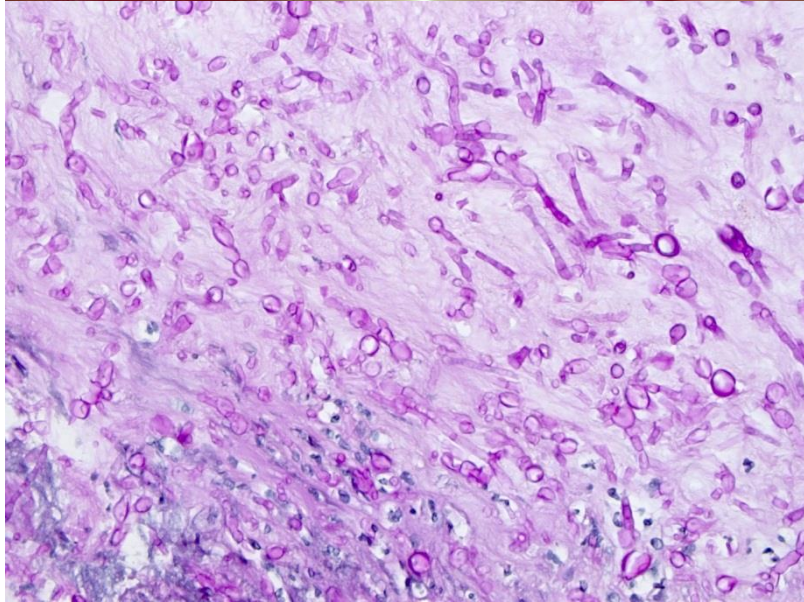
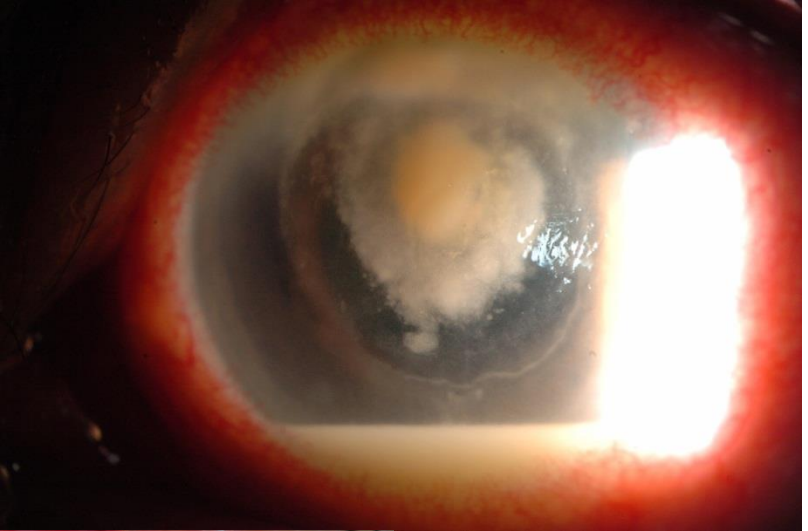
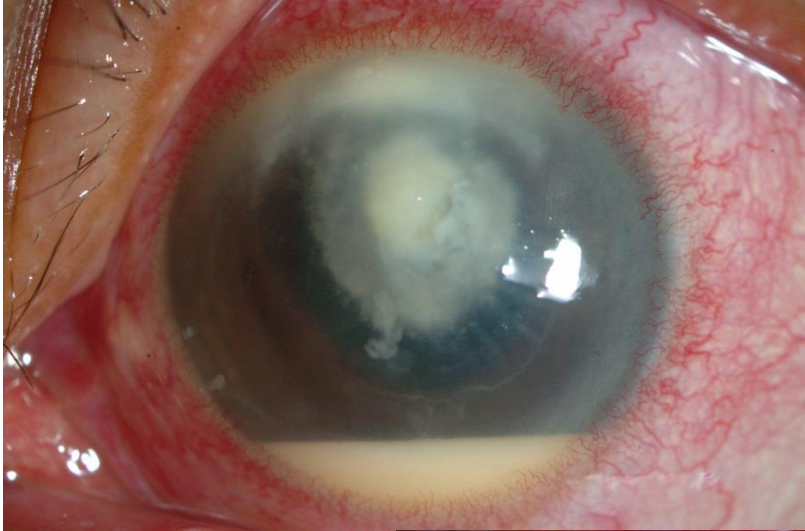


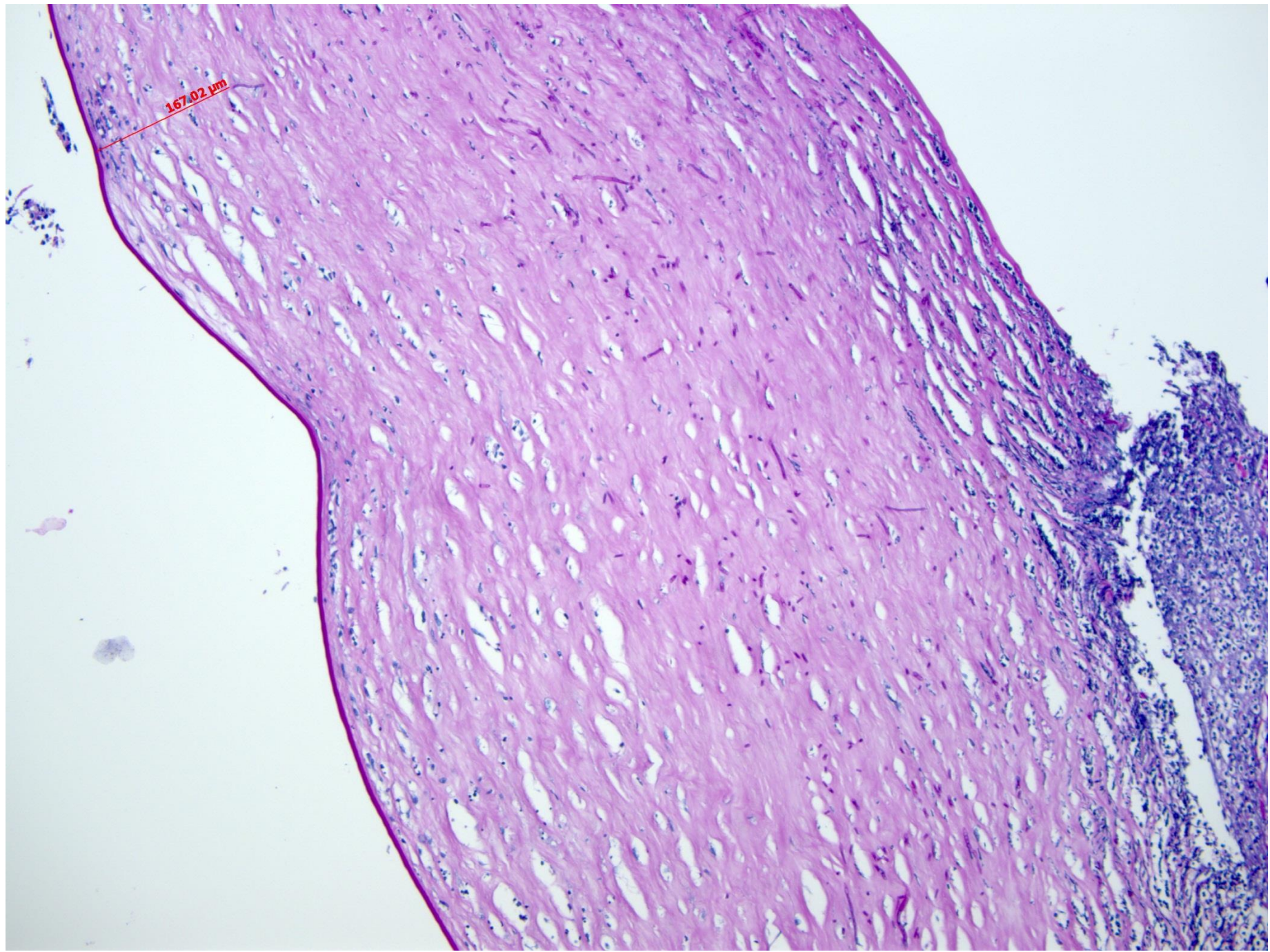
1. Prélèvements locaux sur la cornée.
2. Corticoïdes topiques.
3. Antibiotiques topiques.
4. Gouttes mydriatiques.



KERATITE INFECTIEUSE

1. Prélèvements locaux sur la cornée
 - En cas de suspicion d'abcès cornéen infectieux, il faut toujours effectuer des prélèvements pour guider l'antibiothérapie.
2. Corticoïdes topiques
 - Un hypopion nécessite une hospitalisation avec des antibiotiques systémiques (iv) et topiques.
 - Pas de corticoïdes topiques sans couvrir une étiologie fongique ou virale
3. Antibiotiques topiques
 - Tant que le germe n'est pas déterminé, il faut traiter à la fois pour une atteinte bactérienne et fongique
4. Gouttes mydriatiques
 - Un traitement mydriatique est utile pour prévenir les spasmes douloureux du corps ciliaire.





QUESTION 2

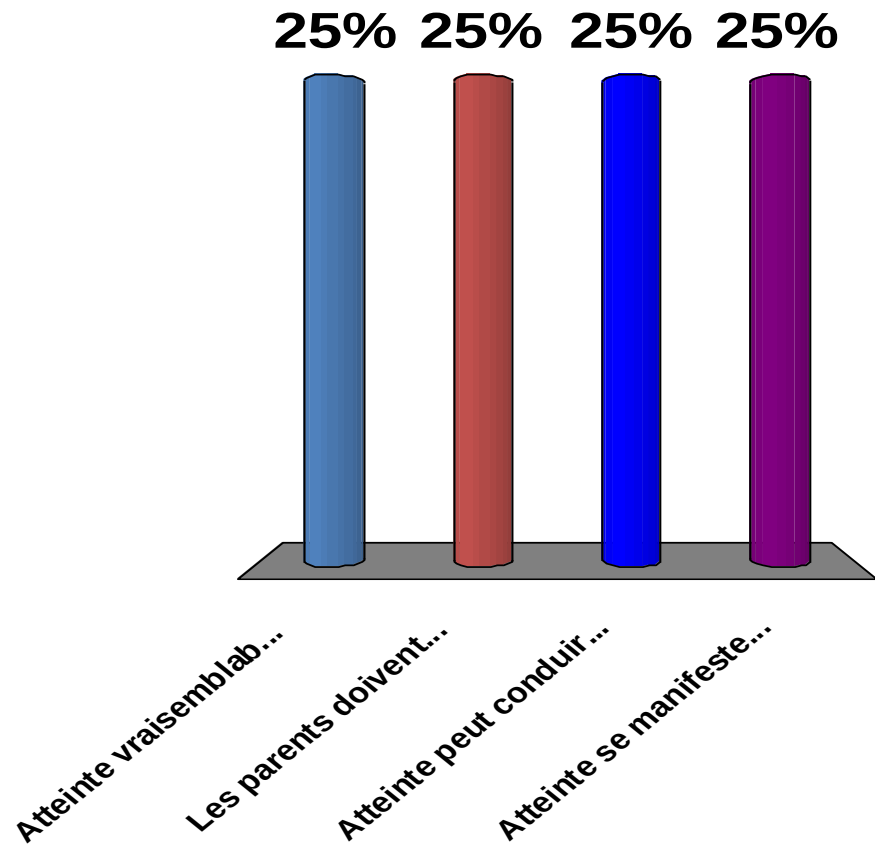
Un nouveau-né présente l'atteinte suivante:



Quelle est l'affirmation fausse?



1. Atteinte vraisemblablement virale
2. Les parents doivent aussi être traités.
3. Atteinte peut conduire à une perforation oculaire.
4. Atteinte se manifeste souvent quelques jours après l'accouchement



CONJONCTIVITES NEONATALES (gonocoques)

1. Cette atteinte est liée à un virus.
 - Non il s'agit d'une atteinte purulente liée à des bactéries ici le gonocoques
2. Les parents doivent aussi être traités.
 - Oui
3. Cette atteinte peut conduire à une perforation oculaire.
 - Oui le gonocoques est capable de pénétrer dans le stroma cornéen même en l'absence de traumatisme local.
4. Cette atteinte se manifeste souvent quelques jours après l'accouchement.
 - La conjonctivite à gonocoques atteint souvent les nouveaux nés dans la première semaine après l'accouchement.

QUESTION 3

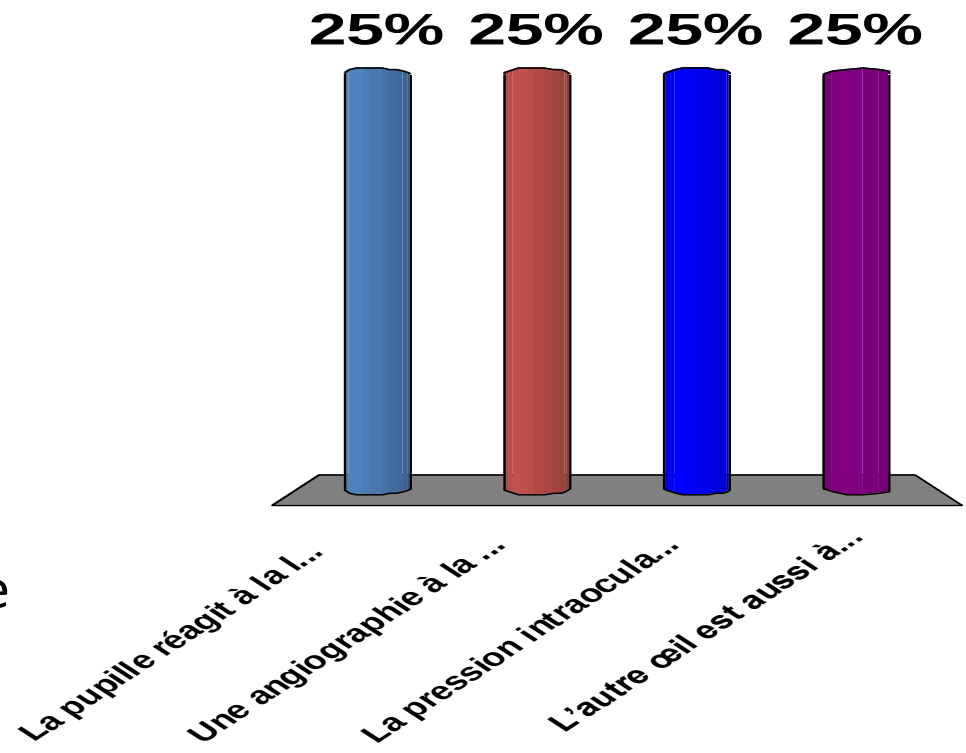
Une femme de 67 ans se plaint d'une importante douleur à l'œil droit depuis 5 heures de temps avec une diminution de son acuité visuelle. Elle se plaint aussi d'importantes nausées.



Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte?



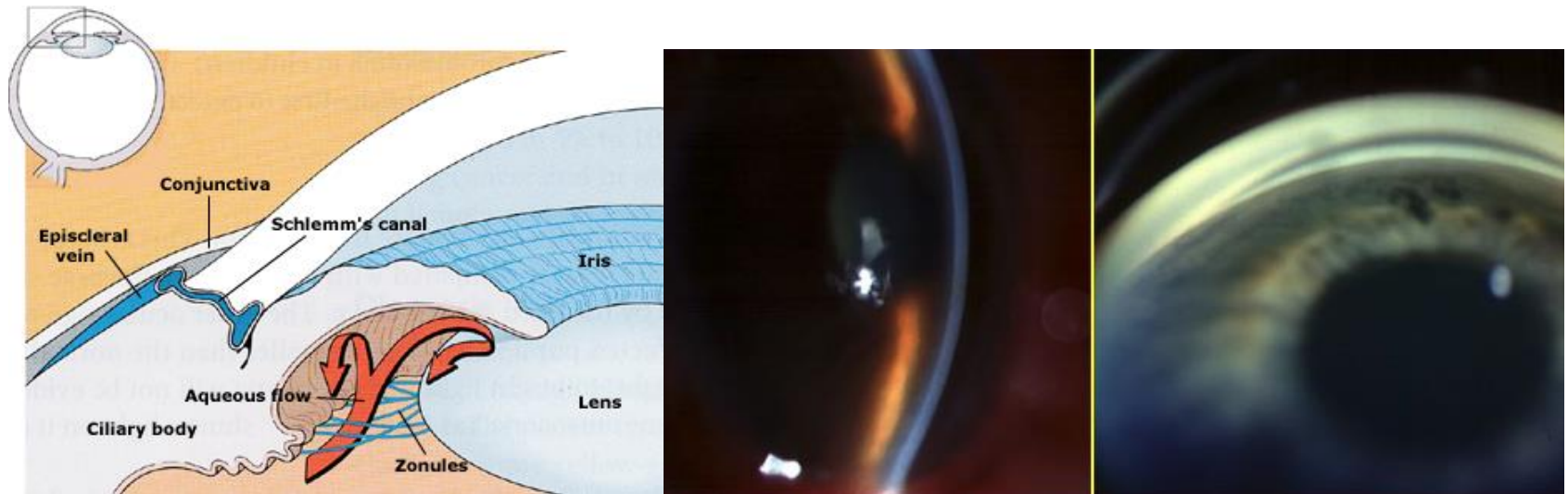
1. La pupille réagit à la lumière
2. Une angiographie à la fluorescéine est indiquée en urgence
3. La pression intraoculaire est normale
4. L'autre œil est aussi à risque de présenter une telle atteinte



GLAUCOME AIGU PAR FERMETURE DE L'ANGLE

1. La pupille réagit à la lumière.
 - Non la pupille est la plupart du temps peu réactive.
2. Une angiographie à la fluorescéine est indiquée en urgence.
 - Non
3. La pression intraoculaire est normale dans ce cas.
 - Non svt > 40 mmHg.
4. L'autre œil est aussi à risque de présenter une telle atteinte.
 - Oui. Comme l'autre œil partage la même configuration anatomique , 40-80% des patients ont une atteinte de l'autre œil dans les 5-10 jours.

GLAUCOME AIGU PAR FERMETURE DE L'ANGLE



Plus fréquent co : femmes, inuits et asiatiques

DD: autre cause oeil rouge (conjonctivite, sclérite, kératite, uvéite): Nausées, vomissements.

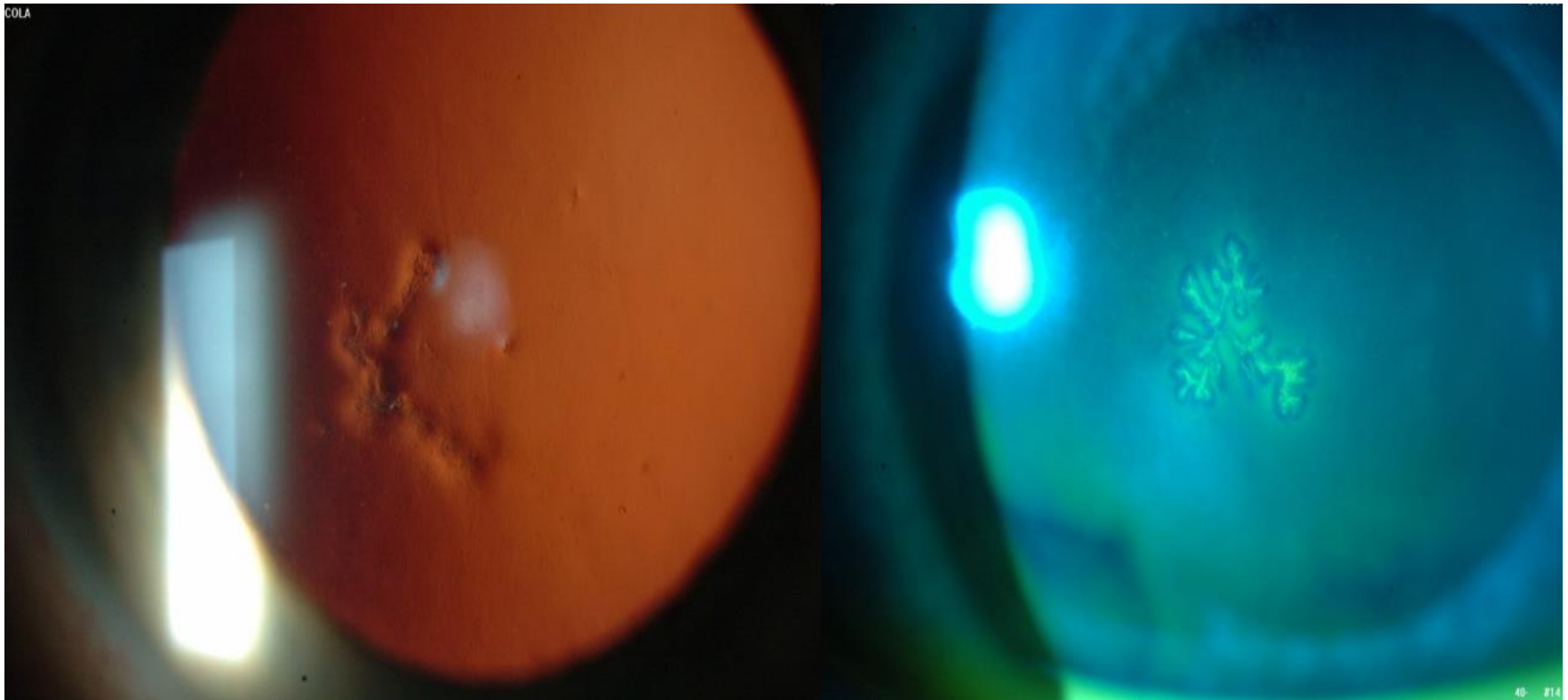
TT: 1° baisser la pression (β bloquant, α_2 agoniste, IAC) et/ou agents osmotiques

: 2° tt «chirurgical» : Iridotomie au laser, éventuellement ablation cataracte

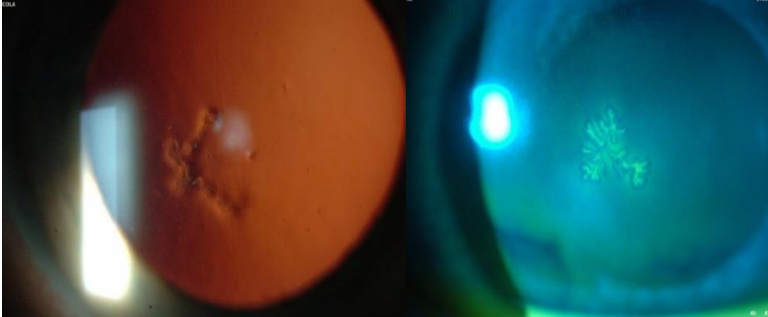
QUESTION 5

Un homme de 35 ans se plaint d'une douleur à l'œil droit. Il ne supporte pas la lumière et son œil est rouge.

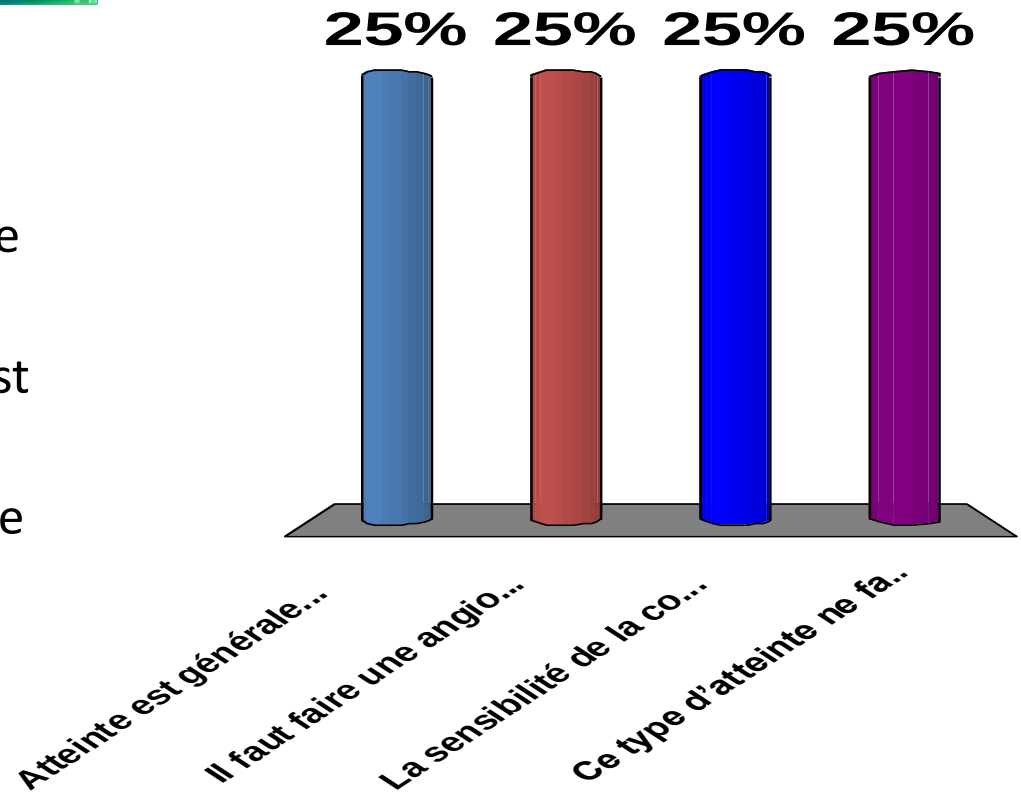
En lampe à fente on retrouve ceci:



Parmi les affirmations suivantes, laquelle est correcte ?



1. Atteinte est généralement bilatérale chez les adultes.
2. Il faut faire une angiographie rétinienne.
3. La sensibilité de la cornée est altérée.
4. Ce type d'atteinte ne fait que rarement des récurrences.



KERATITE HERPETIQUE

Parmi les affirmations suivantes, laquelle est correcte:

1. Cette atteinte est généralement bilatérale chez les adultes.
 - Non, unilatérale le plus souvent (88-98% adultes; 74-97% enfants).
2. Dans ce cas, il faut aussi effectuer une angiographie
 - Si l'atteinte est limitée à la cornée, il n'y a pas d'indication à une angiographie.
3. Dans ce cas, la sensibilité de la cornée est altérée.
 - Oui. La sensibilité cornéenne est généralement diminuée.
4. Ce type d'atteinte ne fait que rarement des récurrences.
 - Non: Herpes is forever.

HERPES : CLINICAL MANIFESTATIONS

- Congenital / neonatal infection (80% HSV2)
- Blepharo-conjunctivitis (primo infection)
- Keratitis
 - Epithelial
 - Stromal
 - Disciform
 - Necrotizing
 - Interstitial
 - Endothelial
- Keratouveitis
- Anterior uveitis $\pm$ increased IOP
- Posterior segment: ARN

RECURRENCE: REACTIVATION

After a first episode of ocular HSV:

10-27% at 1 year

25-45% at 2 years

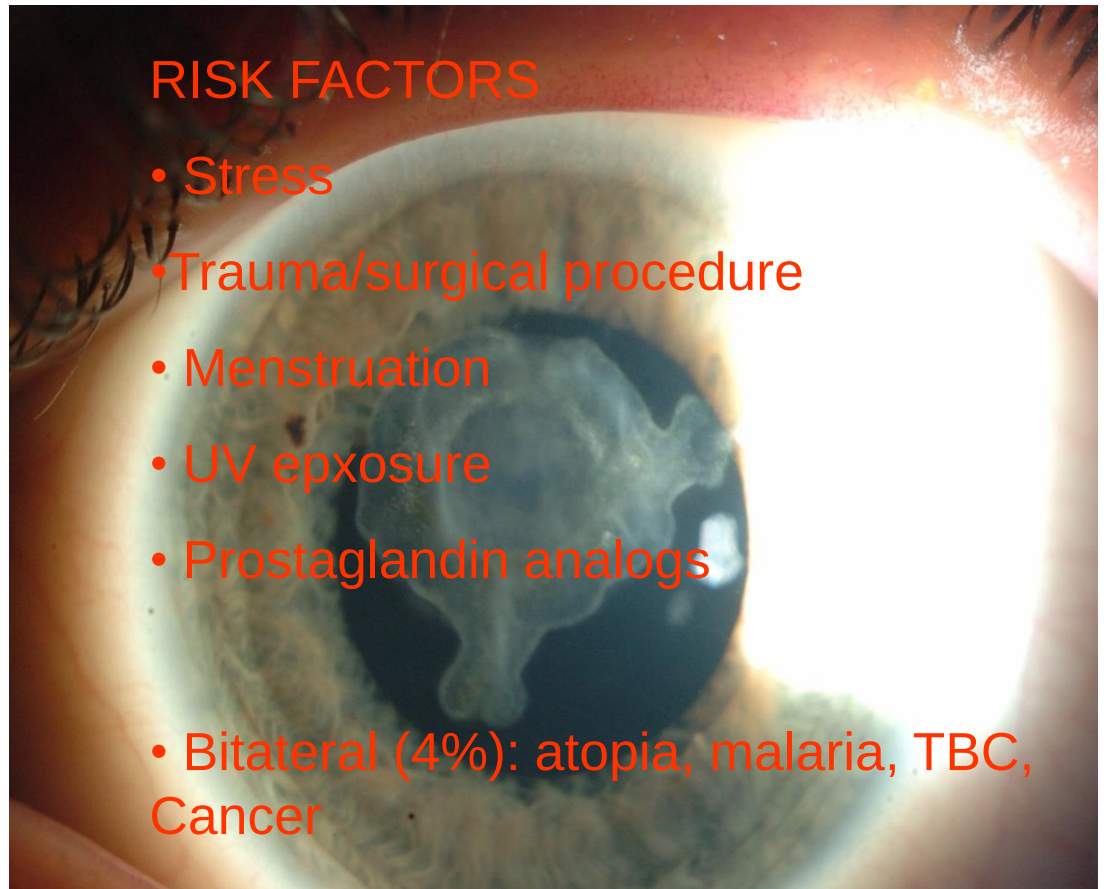
36-50% at 5 years

57% at 10 years

63% at 20 years

RISK FACTORS

- Stress
- Trauma/surgical procedure
- Menstruation
- UV exposure
- Prostaglandin analogs
- Bitateral (4%): atopia, malaria, TBC, Cancer



QUESTION 6

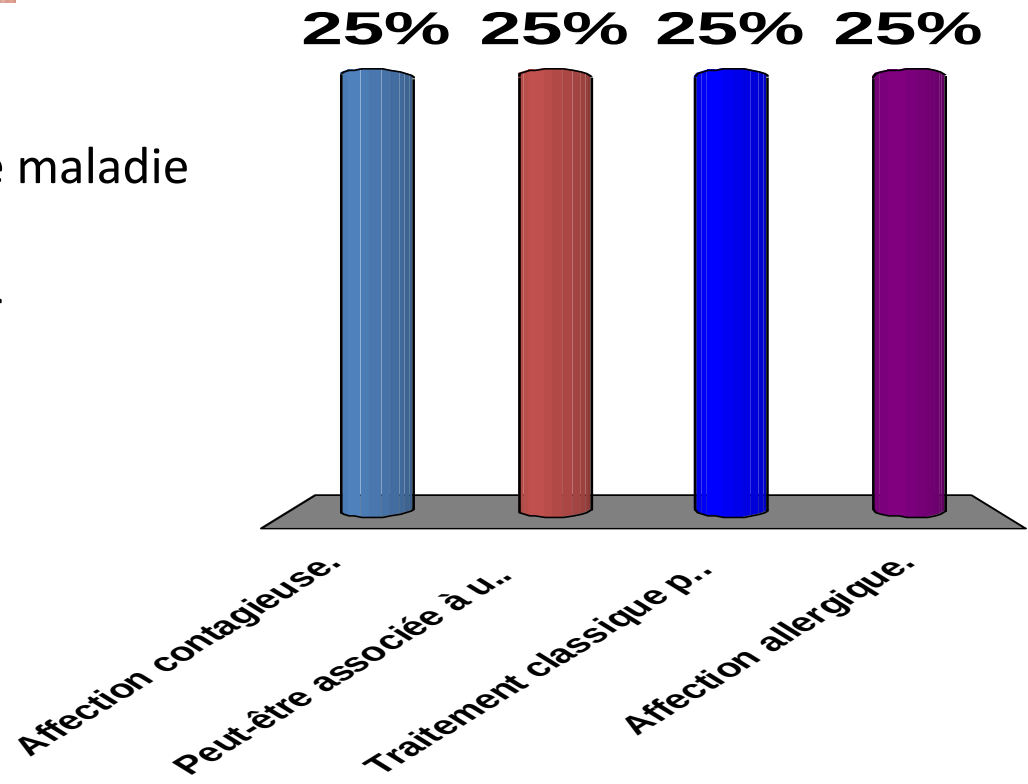
Une femme de 49 ans qui a souvent mal dans les articulations des mains présente depuis 1 jour une importante douleur de l'œil gauche qui l'empêche de dormir. La douleur irradie dans le visage. Son œil est ainsi:



Parmi les affirmations suivantes laquelle est correcte?



1. Affection contagieuse.
2. Peut-être associée à une maladie auto-immune.
3. Traitement classique par antibiotiques.
4. Affection allergique.



Sclérite antérieure

1. Affection contagieuse
 - Non, une atteinte infectieuse dans les sclérites est rare (7.5%) svt., liée à HSV
2. Peut être associée à une maladie auto-immune.
 - Oui, jusqu'à 50% des sclérites sont associées à une maladie auto-immune (polyarthrite rhumatoïde, lupus, Wegener, PAN, polychondrite)
3. Traitement classique par des antibiotiques.
 - Non le tt. de choix comprend des AINS per os et si pas efficaces stéroïdes po.
4. Affection allergique.
 - Non

QUESTION 7

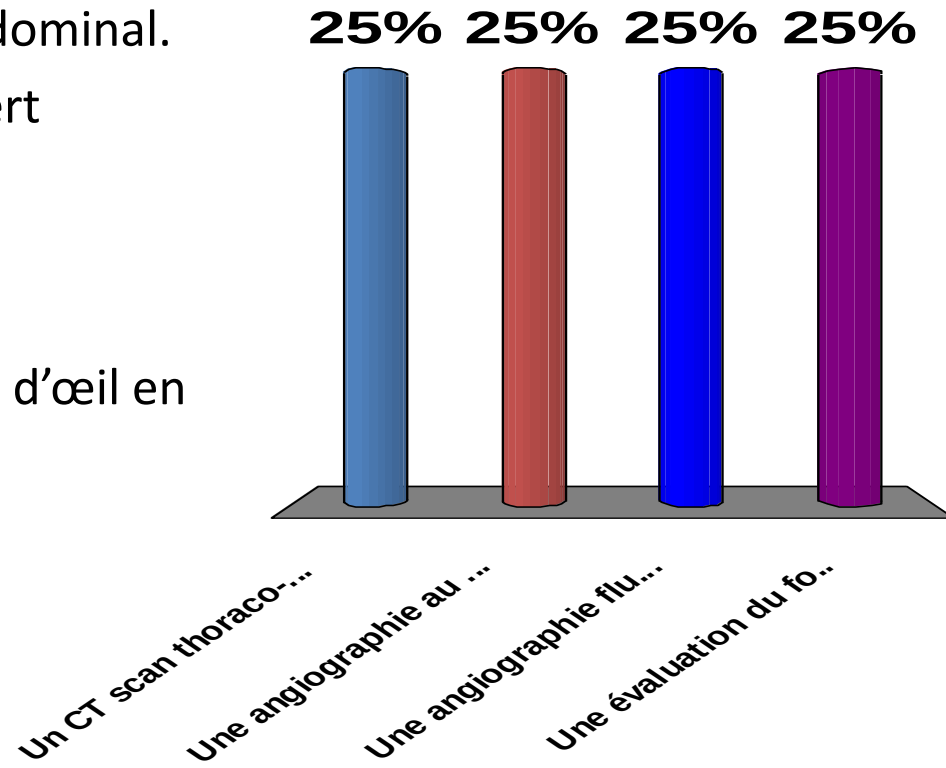
Quelle est l'investigation la plus appropriée chez cet enfant?



Quelle est l'investigation la plus appropriée chez cet enfant?



1. Un CT scan thoraco-abdominal.
2. Une angiographie au vert d'indocyanine.
3. Une angiographie fluoréscéinique.
4. Une évaluation du fond d'œil en anesthésie générale.



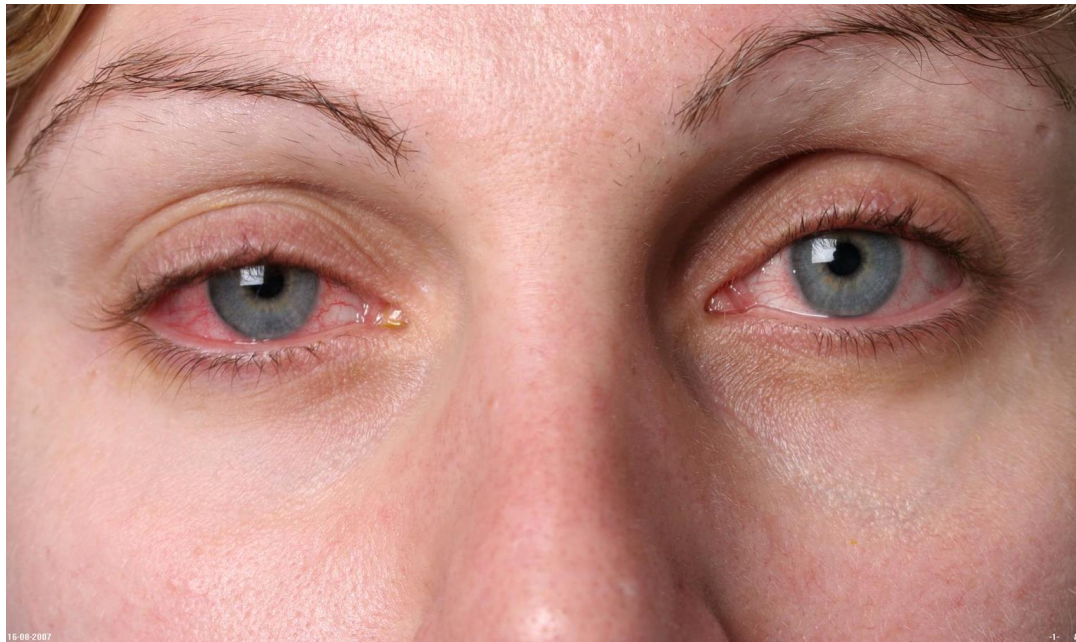
Leucocorie

Parmi les affirmations suivantes laquelle est correcte:

1. Un CT scan thoraco-abdominal.
 - Non, il faut exclure un rétinoblastome et non une métastase.
2. Une angiographie au vert d'indocyanine.
 - Pas indiquée dans ce cas. Cet examen est utile pour évaluer des pathologies de la choroïde.
3. Une angiographie fluoréscéinique.
 - Peut-être utile mais ce n'est pas l'examen essentiel dans ce cas.
4. Une évaluation du fond d'œil en anesthésie générale.
 - C'est l'examen de choix dans ce cas (DD leucocorie : Rétinoblastome, cataracte congénitale, persistance du vitré primaire, Toxocara, maladie de Coats, rétinopathie du prématuré)

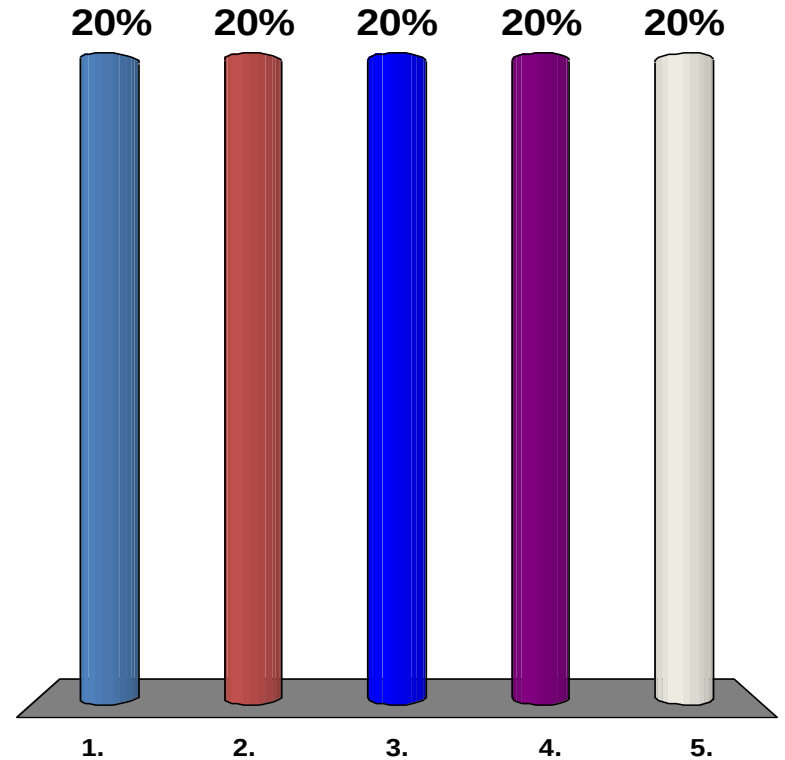
QUESTION 8

Cette patiente consulte pour des yeux rouges, qui piquent et brûlent depuis 20 jours. Son acuité visuelle est normale. Elle a remarqué que cet épisode survenait toutes les années au printemps.



Quel diagnostic est le plus probable

1. Conjonctivite bactérienne
2. Conjonctivite virale
3. Conjonctivite allergique
4. Rosacée oculaire
5. Conjonctivite ligneuse



Conjonctivite allergique saisonnière

- Pourquoi?
 - Prurit, épiphora
 - Symptomatologie
 - Récurrence annuelle
- Mécanisme
 - Histamine
- Traitement
 - Anti-histaminiques topiques
 - Anti-histaminiques systémiques
 - Stabilisateurs mastocytes
(corticoïdes)



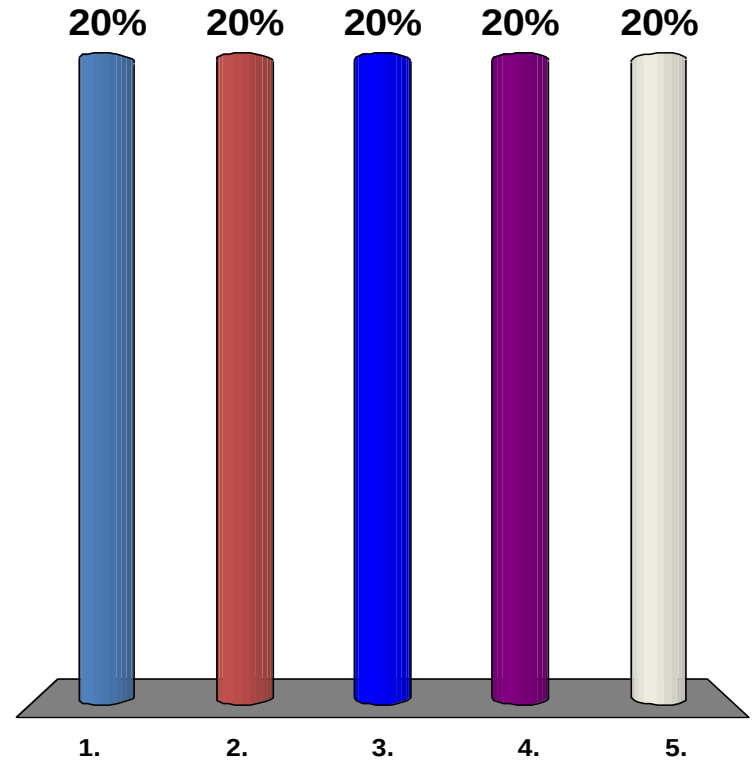
QUESTION 9

Cet homme de 78 ans, consulte pour une éruption maculo-papuleuse, crouteuse de l'hémiface supérieure droite, évoluant depuis 10 jours. Il a de violentes douleurs de la face qui sont associées. Son acuité visuelle est diminuée et il existe une kératite de l'œil droit. La chambre antérieure est calme.



Quel diagnostic évoquez-vous?

1. Impétigo de la face
2. Kératite herpétique
3. Herpès oculo-cutané
4. Zona cutané
5. Zona oculo-cutané



Zona oculo-cutané du V1 droit

- Pourquoi?
Topologie (dermatome V1)
Âge
- Dgs différentiels:
Herpès oculo-cutané

